Neumonía

FISIOPATOLOGIA · Clase 27 · del germen que entra por la orofaringe al alveolo lleno de exudado: el pulmón se vuelve sólido

1 · QUÉ ES LA NEUMONÍA

Neumonía F1
inflamación del parénquima con alvéolos llenos de exudado; el pulmón sólido se llama síndrome de condensación

se clasifica por el lugar en

Según el lugar
NAC (fuera del hospital o primeras 48 h), nosocomial (más resistente) e inmunocomprometidos

se favorece por los

Factores de riesgo
tabaco, ancianos, alcoholismo, diabetes, EPOC, inmunosupresión y conciencia alterada

según su gravedad se decide la

2 · CÓMO ENTRA EL GERMEN

entra sobre todo por

Aspiración orofaríngea F2 · F4
50 % de los casos; flora mezclada aerobia y anaerobia

bajan las defensas y favorecen la

trae sobre todo gérmenes

también entra por otras

Otras vías
inhalación (Legionella), hematógena (ITU) y continuidad (absceso hepático)

trae sobre todo gérmenes

3 · TÍPICAS Y ATÍPICAS

Atípicos F5
Mycoplasma, Legionella, Chlamydia y virus; no colonizan las vías aéreas sanas

inflaman el alvéolo y dejan

Típicos F5
neumococo, Haemophilus, estafilococo y gram negativos; colonizan las vías aéreas

si toma un lóbulo se llama

Lobar o bronconeumonía F3
la lobar toma un lóbulo (fases 🛍️: congestión, hepatización roja y gris, resolución); la bronconeumonía es de focos múltiples y de ancianos

con hipoxemia marca la

4 · EL ALVÉOLO SE LLENA

Exudado alveolar F1
líquido, neutrófilos y fibrina desplazan el aire del alvéolo

inflaman el alvéolo y dejan

al llenar el alvéolo produce el

Pulmón sólido F8
no ventila (hipoxemia) y conduce mejor el sonido y las vibraciones

activa la respuesta sistémica con

al tocar la pleura produce

al examen físico da

5 · SÍNTOMAS Y SIGNOS

Disnea
menos parénquima que ventila y dolor que limita la expansión

reduce el parénquima útil y causa

Fiebre, escalofríos y tos
tos seca y luego mucopurulenta; la fiebre puede faltar en el diabético

Dolor pleurítico F6
parénquima no tiene inervación dolorosa: duele la pleura parietal

Examen físico F7 · F8
menos expansión, vibraciones aumentadas y matidez; crepitantes, soplo tubárico, broncofonía y pectoriloquia en vez del murmullo

6 · DIAGNÓSTICO Y GRAVEDAD

Gravedad
cianosis o SatO2 menor de 90 %; hospitalizar, oxígeno y antibiótico EV

Hemograma F9
leucocitosis = bacteria; linfocitosis = virus; leucopenia = mal pronóstico

en la sangre se ve en el

se confirma con la

en el joven con tos seca da el

se alivia con

sin tratamiento correcto produce

si es grave exige

Radiografía F15
opacidad homogénea de bordes poco nítidos con broncograma aéreo (bronquios con aire en pulmón opaco)

si baja, anuncia riesgo de

obliga a descartar el

se complementa con

orienta la elección del

Cultivos y TC
hemocultivo útil solo en 6-20 %; esputo controvertido; TC si hay dudas

Diagnóstico diferencial
TEP, TBC, edema agudo de pulmón, atelectasia, neoplasia y quiste hidatídico

7 · COMPLICACIONES

Derrame paraneumónico F13
la inflamación se extiende a la pleura

si es grave indica

si progresa causa

Insuficiencia respiratoria aguda
falta de oxígeno por neumonía extensa

si hay necrosis forma un

Absceso pulmonar
necrosis del parénquima con cavitación

Empiema pleural
pus en la pleura; requiere drenaje

al diseminarse produce

Septicemia
bacteriemia sostenida con respuesta inflamatoria sistémica

sin control termina en

Shock séptico F13
hipotensión refractaria a volumen; mortalidad elevada

al romper a la pleura da

8 · TRATAMIENTO

Medidas generales
reposo con movimiento de las piernas (previene TVP y TEP), hidratación, oxígeno si SatO2 < 90 %, analgésicos y dieta hipercalórica

Joven con tos seca F14
opacidades intersticiales = Mycoplasma pneumoniae, se trata con macrólido

se trata con

Antibiótico F10
atípicos: macrólidos (alternativa, tetraciclinas); hospitalizados: macrólidos y fluoroquinolonas EV

en UCI con Pseudomonas se usa

Pseudomonas en UCI F11
imipenem + ciprofloxacino o levofloxacino por vía parenteral

se evalúa a las

Sin mejoría F12
no mejora en 48-72 horas con el tratamiento indicado

se mantiene por

Duración
7-10 días; si el paciente sigue mal, 15-20 días

obliga a

Reevaluar F12
buscar error diagnóstico, sobreinfección, TBC, TEP o neoplasia

si no se piensa explica la falta de

concepto · causa · ejemplo · mecanismo · síntoma · signo · diagnóstico · complicación · desenlace · borde dorado = alto rendimiento · F# = pregunta n.º # de la lámina

Fuente: Clase 42 · Dr. Sotito — teoría del docente (🛍️ = literatura)